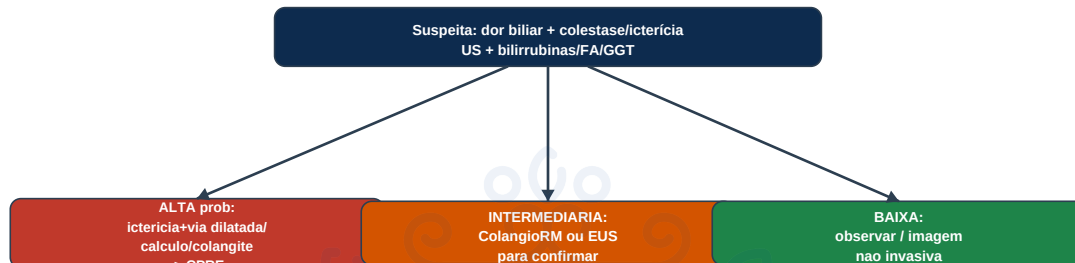


COLEDOCOLITÍASE — PROBABILIDADE + CPRE

FLUXOGRAMA — ESTRATIFICAR PROBABILIDADE

COLEDOCOLITÍASE — PROBABILIDADE GUIA A INVESTIGAÇÃO



DEFINIÇÃO E APRESENTAÇÃO

CÁLCULO NO COLÉDOCO

- Cálculo no ducto colédoco -> obstrução biliar parcial/total; 10-20% dos portadores de colelitíase
- Icterícia OBSTRUTIVA: icterícia progressiva, COLÚRIA e ACOLIA fecal
- Colestase isolada: prurido, elevação de FA/GGT
- Pode complicar com COLANGITE (Charcot: dor HD + febre + icterícia) ou PANCREATITE biliar
- Reynolds (colangite grave): Charcot + choque + alteração do nível de consciência

IMAGEM

Exame	Papel
US abdominal	1ª linha; sensível para DILATAÇÃO (> 6 mm); detecção direta do cálculo só ~50-70%
ColangioRM (MRCP)	Alta sensibilidade/especificidade; não invasiva — define necessidade de terapia
EUS	Altíssima sensibilidade para cálculos pequenos (< 5 mm); útil se US inconclusivo
CPRE	Diagnóstica E terapêutica — indicar quando alta probabilidade/colangite (não só como exame)

ESTRATIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE

GUIA A CONDUTA

- ALTA (-> CPRE terapêutica): icterícia obstrutiva + via dilatada/cálculo visível; colangite (independe da imagem); pancreatite biliar com obstrução persistente
- INTERMEDIÁRIA: enzimas alteradas sem icterícia clara, ou US com dilatação sem cálculo -> ColangioRM/EUS para confirmar
- BAIXA: dor biliar isolada com exames normais e US sem dilatação -> observar / imagem não invasiva antes da CPRE
- Evitar CPRE puramente diagnóstica (risco de pancreatite pós-CPRE)

TRATAMENTO

Rx CONDUTA NO PS + TERAPIA DEFINITIVA

Inicial: estabilização, jejum (se previsão de endoscopia/cirurgia), analgesia e antiemético; hemoculturas se febre/colangite
Analgesia: Dipirona 1 g EV 6-8/8h; Tramadol 50-100 mg 8/8h; Ondansetrona 4 mg EV ou Metoclopramida 10 mg EV
ATB: NÃO de rotina se sem infecção; se COLANGITE -> Pipe-tazo 4,5 g 6-8/8h ou Ceftriaxona 2 g/dia + Metronidazol 500 mg 8/8h
DEFINITIVO: CPRE com papilotomia + extração (balão/cesto) ± litotripsia ± stent temporário
CPRE urgente: colangite, obstrução com sepse, pancreatite com obstrução persistente; precoce (24-72h): icterícia obstrutiva significativa
Alternativas: exploração cirúrgica do colédoco; drenagem trans-hepática percutânea se CPRE inviável
COLECISTECTOMIA após resolução — idealmente na MESMA internação — para prevenir recorrência

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: icterícia obstrutiva sintomática, dor não controlada, suspeita de colangite/infecção, pancreatite associada, comorbidades
- ☐ ALTA do PS apenas se: sintomas leves, sem icterícia nem alteração laboratorial, com acesso e retorno rápido
- ☐ Plano de seguimento/colecistectomia sempre definido na alta
- ☐ Complicações da CPRE: pancreatite pós-CPRE, sangramento pós-esfinterotomia, perfuração, cálculo residual
- ☐ Diferencie de colecistite: coledocolitíase causa colestase/icterícia e pode evoluir para colangite/pancreatite

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com dor biliar + icterícia ____; colúria/acolia ____; febre ____ (colangite?).
- Bilirrubinas ____, FA/GGT ____, amilase/lipase ____; US: via biliar ____ mm, cálculo ____; probabilidade: alta/intermediária.
- Hemoculturas ____; ATB (se colangite) ____ às ____; analgesia/antiemético.
- Solicito: () CPRE urgente (colangite/sepse) () CPRE 24-72h (icterícia obstrutiva) () avaliação cirúrgica / UTI.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com icterícia obstrutiva, US com via biliar dilatada e cálculo visível no colédoco, sem febre. Qual a conduta definitiva de escolha?

- A) Colecistectomia isolada
- B) CPRE terapêutica (papilotomia + extração do cálculo)
- C) Apenas antibiótico
- D) Observação ambulatorial
- E) Colangiorressonância seriada

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com enzimas hepáticas alteradas, sem icterícia clara, US com discreta dilatação biliar sem cálculo visível (probabilidade intermediária). Qual o próximo passo?

- A) CPRE diagnóstica imediata
- B) Colangiorressonância (MRCP) ou EUS para confirmar antes de CPRE
- C) Cirurgia exploradora imediata
- D) Alta sem investigação
- E) Antibiótico empírico prolongado

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Após resolução endoscópica da coledocolitíase em paciente com vesícula calculosa, qual a conduta para prevenir recorrência?

- A) Apenas dieta
- B) Colecistectomia, idealmente na mesma internação
- C) Repetir CPRE eletiva
- D) Ácido ursodesoxicólico por toda a vida
- E) Nenhuma medida adicional

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual a tríade de Charcot, que sugere colangite na coledocolitíase?

- A) Dor + vômito + diarreia
- B) Dor em hipocôndrio direito + febre + icterícia
- C) Febre + hipotensão + confusão
- D) Icterícia + prurido + colúria
- E) Dor + massa + emagrecimento

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre a sensibilidade do US para coledocolitíase, é correto:

- A) Detecta diretamente o cálculo no colédoco em quase 100% dos casos
- B) É sensível para a dilatação da via biliar, mas a detecção direta do cálculo é de apenas ~50-70%
- C) É o exame definitivo, dispensando outros
- D) Não avalia a via biliar
- E) Substitui sempre a colangiorressonância

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Com alta probabilidade (icterícia obstrutiva + cálculo/via dilatada), a CPRE terapêutica (papilotomia + extração) é o método de escolha. A colecistectomia é feita depois, para prevenir recorrência.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Na probabilidade intermediária, confirma-se com ColangioRM (MRCP) ou EUS antes de submeter o paciente à CPRE, que tem risco de pancreatite pós-procedimento e não deve ser apenas diagnóstica.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A colecistectomia, idealmente na mesma internação após resolução da obstrução, previne a recorrência em pacientes com vesícula calculosa concomitante.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A tríade de Charcot é dor em hipocôndrio direito + febre + icterícia, sugestiva de colangite. A tríade de Reynolds acrescenta choque e confusão (colangite grave).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O US é sensível para a dilatação da via biliar, mas a detecção direta do cálculo no colédoco é de apenas ~50-70% e operador-dependente — daí o papel da ColangioRM/EUS na confirmação.

SM24
Suporte ao Plantão Médico